



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana

**“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS-CLÍNICAS DE PACIENTES
CON DENGUE, CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA, SAN
JUAN DE LURIGANCHO, 2023”.**

**PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MÉDICO
CIRUJANO**

Presentado por:

AUTOR: ANAYA ALBINAGORTA, ANGELA VANNESSA

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4405-4460>

ASESOR: DR. GONZALES CARRILLO, JAVIER JOSÉ

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3315-0657>

LINEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD Y BIENESTAR

LIMA, PERÚ

2024

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS.....	5
1. EL PROBLEMA.....	6
1.1. Planteamiento del problema	6
1.2. Formulación de la investigación	9
1.2.1. Problema general	9
1.2.2. Problemas específicos	9
1.3. Objetivos de la investigación	9
1.3.1. Objetivo general.....	9
1.3.2. Objetivos específicos	9
1.4. Justificación de la investigación.....	10
1.4.1. Teórica	10
1.4.2. Metodológica	10
1.4.3. Práctica.....	11
1.5. Delimitación de la investigación	12
1.5.1. Temporal	12
1.5.2. Espacial	12
1.5.3. Población o unidad de análisis.....	12
2. MARCO TEÓRICO	13
2.1. Antecedentes	13
2.1.1. Antecedentes internacionales.....	13
2.1.2. Antecedentes nacionales	16
2.2. Bases teóricas	19
2.2.1. Dengue	19

3.	METODOLOGÍA.....	31
3.1.	Método de investigación	31
3.2.	Enfoque de la investigación	31
3.3.	Tipo de investigación	31
3.4.	Diseño de investigación	32
3.5.	Población, muestra y muestreo.....	33
3.5.1.	Población	33
3.5.2.	Muestreo	33
3.5.3.	Muestra	34
3.6.	Variable y operacionalización.....	34
3.6.1.	Variable.....	34
3.6.2.	Operacionalización de la variable.....	35
3.7.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	35
3.7.1.	Técnicas	35
3.7.2.	Descripción de instrumentos.....	35
3.8.	Plan de procesamiento y análisis de datos	38
3.9.	Aspectos éticos.....	38
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	40
4.1.	Cronograma de actividades	40
4.2.	Presupuesto.....	40
5.	REFERENCIAS	42

ANEXOS.....	50
Anexo 1. Matriz de consistencia.....	51
Anexo 2. Ficha documental sobre características epidemiológicas-clínicas y signos de alarma en el dengue	52
Anexo 3. Formato de validación del instrumento.....	53
Anexo 4. Llenado del formato de validación del instrumento por los expertos.....	59
Anexo 5. Ficha de investigación clínico epidemiológica de Dengue del centro de salud.....	65

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables	36
Tabla 2. Cronograma de actividades	40
Tabla 3. Presupuesto.....	41

1. EL PROBLEMA

1.1.Planteamiento del problema

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el dengue es una infección de tipo vírica, que tiene como vector a los mosquitos hembra que se encuentren infectados con dicho virus, siendo el más común el *Aedes aegypti*, entre otras especies del género *Aedes*. Si bien para la mayoría de las personas con esta condición, no se observa síntoma alguno, en los casos que sí se observa sintomatología, puede variar desde síntomas leves, que incluyen fiebre, dolor muscular, articular y de cabeza, náuseas y ganglios linfáticos agrandados, hasta signos de alarma, como dolor abdominal, vómitos persistentes, hemorragias y debilidad general; y en los casos más graves pueden causar la muerte¹.

En un estudio que revisó la carga mundial del dengue entre 1990 y 2019, se observó que ha habido un aumento gradual tanto en la incidencia del dengue como en las muertes causadas por este y en la tasa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) derivada del mismo. Sin embargo, revelan que ha habido cambios en la distribución por edad y variables sociodemográficas, siendo más común ahora en el grupo de 15 a 49 años, en contraste con una mayor proporción anterior en el grupo menor de 5 años; y una mayor incidencia en el grupo de ingresos medio-alto a alto, en contraste con una mayor incidencia en los estratos más bajos. En cuanto a la distribución geográfica, mientras que Asia presenta una

mayor prevalencia, mortalidad y AVAD, América Latina Tropical presentó la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad².

Si se toma en cuenta lo anterior, y el hecho de que se estima un rango de 100 a 400 millones de nuevos casos de dengue al año³, se entiende que se trata de un problema de gran y creciente magnitud y que se encuentra vigente, sin una solución integral a puertas, si bien se están realizando estudios para el desarrollo de vacunas tetravalentes que ataquen los cuatro serotipos del dengue, y nuevas técnicas para el control de vectores. Sin embargo, mientras estos avances terminan de tomar forma, es necesario atender a la problemática más palpables de nuevos brotes y epidemias en distintas regiones geográficas del mundo.

Así pues, y como ya se ha adelantado, si bien el dengue es un problema de salud pública global, en los últimos años ha afectado con particular intensidad a Latinoamérica y el Caribe. En un estudio realizado en México, Centroamérica y Suramérica con data de 1998 a 2018, se observó que en todo el periodo Brasil fue el país más afectado, con Argentina y Chile como los menos afectados. El periodo con la mayor incidencia fue de 2012 a 2016, con una caída en los últimos dos años de estudio⁴.

En otro estudio, tomado desde 1980 hasta 2024, se registraron casi 40 millones de casos en toda América Latina y el Caribe, de los cuales más de 25 millones corresponden a Brasil. Esto significa una incidencia de casi 900 mil casos anuales de dengue en esta región durante todo el periodo estudiado. Los siguientes seis países más afectados fueron México, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Paraguay y Perú⁵. Sin embargo, si se toma en cuenta la proporción de casos por habitantes, Brasil sigue estando en primera posición, pero ahora seguido de Bolivia, Paraguay y Perú, con entre 800 y 1400 casos por cada 100 mil habitantes. Los demás países

estarían por debajo de 300/100,000 habitantes. Con la proporción de muertes, Brasil también lidera, con 1094/100,000, seguido de Perú, con 441/100,000. Los demás países tienen una proporción inferior a 200/100,000 ⁶.

En ese marco, se ha observado que Perú no se ha caracterizado particularmente por tener una incidencia tan elevada, pero las alarmas se activan cuando se atiende a la proporción por habitantes, tanto del contagio como de las muertes, que son de las más elevadas de la región. Según la Sala Situacional de Dengue del Ministerio de Salud del Perú, del año 2018 al presente el número de casos de dengue no ha parado de aumentar, pasando de cerca de 4700 casos en 2018 a más de 250 mil en 2024, y más de 60 mil casos solo tomando en cuenta las primeras 10 semanas del 2024. En el mismo corte de 10 semanas, para el año anterior, los casos reportados eran de poco más de 19 mil. Además, la discrepancia entre casos confirmados y probables es mayor en la actualidad, comparando los casi mil casos probables en el corte de 10 primeras semanas de 2023, en contraste con más de 23 mil en dicho rango del 2024 ⁷.

En ese sentido, por el incremento de casos la presente investigación busca comprender de manera profunda y detallada las características epidemiológicas-clínicas de los pacientes con diagnóstico de dengue atendidos en el Centro de Salud en San Juan de Lurigancho, durante el rebrote de dengue del año 2023, lo mismo que permitirá reconocer y estudiar la presentación clínica en la población de estudio, logrando una atención adecuada y diagnóstico más ajustados a las guías de atención elaboradas por organismos multilaterales y nacionales. Lo cual esto puede permitir que en el primer nivel de atención se reduzcan los errores, que se mejore el pronóstico de los pacientes afectados y eventualmente que haya una reducción en las tasas de discapacidad o muerte.

1.2. Formulación de la investigación

1.2.1. Problema general

¿Cuáles son las características epidemiológicas-clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son las características epidemiológicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023?
- ¿Cuáles son las características clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar cuáles son las características epidemiológicas-clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023.

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar cuáles son las características epidemiológicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023.

- Determinar cuáles son las características clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

Aunque las características epidemiológicas-clínicas del dengue se han estudiado con anterioridad por diversos investigadores y diversos contextos, debe tomarse en cuenta que estas características pueden cambiar entre una y otra zona, incluso dentro de un mismo país, por lo cual se entiende que la teoría siempre puede seguirse alimentando de estudios locales, como el presente, que puedan ampliar la comprensión global del tema. De esta forma, se consigue mantener con vida el debate entre los académicos interesados en esta línea de investigación.

1.4.2. Metodológica

Cada centro de salud, dependiendo de su tamaño, recursos y población a la que atiende, tiene una realidad diferente, que puede requerir el desarrollo de instrumentos de recolección de datos personalizados, lo que aplica para el presente caso, en donde las limitaciones en recursos humanos, estructurales y económicos lleva a que se realice una recolección de información más limitada que en otros establecimientos de salud a nivel nacional. En ese sentido, para el presente estudio se ha diseñado un instrumento de recolección de datos que atiende estas limitaciones y que podría servir de referencia para investigadores que deban enfrentarse a una

población con características similares, o bien podrían replicar en sus propios estudios.

1.4.3. Práctica

Contar con información acerca de las características epidemiológicas-clínicas de los pacientes con dengue que asistieron al Centro de Salud Santa Rosa de Lima, durante el brote nacional de dengue del año 2023, permite valorar de forma más precisa qué factores se encuentran más presentes durante brotes de esta naturaleza, lo que puede ser fundamental de cara a enfrentar futuros brotes de dengue, pues puede permitir establecer mecanismos de prevención o preparación institucional.

1.5.Delimitación de la investigación

1.5.1. Temporal

Este estudio tomará en cuenta las bases de datos de historias clínicas y fichas epidemiológicas recolectadas entre el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

1.5.2. Espacial

Este estudio se ejecutará en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, San Juan de Lurigancho, Lima.

1.5.3. Población o unidad de análisis

La unidad de análisis del estudio la conformarán los pacientes con prueba positiva para el diagnóstico de dengue, que fueron atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedentes internacionales

Estrada et al. (2024) realizaron una investigación, titulada “Características epidemiológicas del dengue en el Ecuador – año 2022. Revisión bibliográfica”, la cual tuvo como objetivo “describir los factores que intervienen en la propagación del dengue y su incidencia dentro del territorio ecuatoriano”⁸. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cualitativo, básico, no experimental y documental, que contó con una muestra de investigaciones de las primeras 48 semanas del 2022, la cual se analizó por medio de las técnicas de revisión bibliográfica. Los resultados indican que “la región Costa las provincias del Guayas, Manabí y el Oro fueron las más afectadas”⁸, con más de 280 casos registrados en la semana con mayor incidencia, mientras que en la sierra llegó a 60 casos en su pico más alto y en la Amazonía, a 140 casos. Al respecto, se puede concluir que la incidencia del dengue en Ecuador está asociada a “las condiciones sociodemográficas, el clima y el turismo”¹⁴, siendo mayor en la temporada de lluvia con clima cálido⁸.

García et al. (2023) realizaron una investigación, titulada “Caracterización clínica y epidemiológica del dengue 2015-2020 Hospital Regional de la Orinoquía ESE”, la cual tuvo como objetivo “realizar una caracterización clínica y epidemiológica del dengue en pacientes en pacientes atendidos

en el Hospital Regional de la Orinoquía entre 2015 a 2020”⁹. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y descriptivo, que contó con una muestra de 3395 casos de dengue, a la que se le aplicó una ficha documental como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que, de los casos estudiados, “51% (1735) corresponden a dengue sin signos de alarma, 47% (1599) a dengue con signos de alarma y el 2% (61) dengue grave, la edad promedio 20 años, entre 9 meses a 94 años, la letalidad correspondió al 0,2%”⁹. Al respecto, se puede concluir que el dengue sigue siendo una causa de morbilidad importante en Colombia⁹.

Silverio-Calderón (2023) realizó una investigación, titulada “Dengue: actualidades, características clínicas epidemiológicas y prevención”, la cual tuvo como objetivo “exponer una actualización de la enfermedad y demostrar la necesidad de realizar acciones comunitarias para control del dengue y su prevención entre los años 2008 hasta el 2022”¹⁰. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cualitativo, básico, no experimental y documental, que contó con una muestra de 183 investigaciones, la cual se analizó por medio de las técnicas de revisión bibliográfica. Los resultados indican que los 4 serotipos constituyen la etiología del dengue, con una infección que atraviesa 3 fases (etapa febril, crítica y de recuperación). Se presentan los factores asociados al dengue grave, como la extravasación intensa de fluidos, hemorragias y afectación de órganos, con otros factores de riesgo generales, como el aumento de temperatura, el cambio de clima, la altitud, latitud y humedad, factores socioeconómicos, nivel de conocimiento y conductas inapropiadas. Al respecto, se puede

concluir que “la ausencia del trabajo epidemiológico disminuye la percepción de riesgo que debe tener la población sobre esta enfermedad”¹⁰.

Ricardo-Rivera et al. (2022) realizaron una investigación, titulada “Mapping Dengue in children in a Colombian Caribbean Region: clinical and epidemiological analysis of more than 3500 cases” [“Mapeo del dengue en niños de una región del Caribe colombiano: análisis clínico y epidemiológico de más de 3500 casos”], la cual tuvo como objetivo “to analyze the epidemiological, clinical, and geospatial behavior of dengue in children in a region of the Colombian Caribbean” [“analizar el comportamiento epidemiológico, clínico y geoespacial del dengue en niños de una región del Caribe colombiano”]¹¹. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y descriptivo, que contó con una muestra de 3611 casos de 0 a 17 años, a la que se le aplicó una ficha documental como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que el 38,6% tuvieron signos de alerta y el 1,1% tuvo dengue grave (estos últimos fueron más frecuentes en mujeres). El rango de 4 a 8 años fue el que tuvo más incidencia, con 1778 casos. Los síntomas más frecuentes fueron la fiebre en todos los casos, las mialgias en más del 70% y las artralgias en más del 60%. Un 9% se encontraron en áreas rurales. Al respecto, se puede concluir que hay una incidencia muy alta de dengue con signos de alarma, mayormente en la zona urbana¹¹.

Cazes et al. (2019) realizaron una investigación, titulada “Brote epidémico de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, 2016: características clínicas y hematológicas de la infección en una población pediátrica”, la cual tuvo como objetivo “describir las características clínicas y hematológicas en

una población pediátrica”¹². En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y descriptivo, que contó con una muestra de 156 casos, a la que se le aplicó una ficha documental como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que las características clínicas “más frecuentes fueron fiebre, cefalea y dolor retroocular. Las alteraciones del laboratorio significativas fueron leucopenia, plaquetopenia y aumento de transaminasas. Se internaron 35 pacientes (23%), 25 (16%) con signos de alarma. No se presentó ningún caso de dengue grave”¹². Al respecto, se puede concluir que “el reconocimiento oportuno de los signos de alarma y el control hematológico resultan fundamentales para detectar a los niños en riesgo y ofrecerles tratamiento de soporte en forma precoz”¹².

2.1.2. Antecedentes nacionales

Valverde y Muñoz (2024) realizaron una investigación, titulada “Características clínicas y epidemiológicas en pacientes adultos mayores con dengue en un establecimiento de salud I-4, Lambayeque 2023”, la cual tuvo como objetivo “Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes adultos mayores diagnosticados con dengue en un establecimiento de salud I-4, Lambayeque 2023”¹³. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y descriptivo, que contó con una muestra de 77 casos, a la que se le aplicó una ficha documental como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que los síntomas más comunes fueron las cefaleas y mialgias, el dolor ocular y de articulaciones, la fiebre, el vómito, el prurito y el dolor lumbar; mientras que los signos de alarma más

comunes fueron los vómitos, el dolor abdominal, la lipotimia, las hemorragias y la alteración del estado mental. Al respecto, se puede concluir que este cuadro fue más común en el grupo de 60 a 69 años, mujeres y sin dengue previo¹³.

Alcántara (2023) realizó una investigación, titulada “Características clínico-epidemiológicas de pacientes con dengue con signos de alarma - Región Tumbes 2018-2022”, la cual tuvo como objetivo “determinar las características clínico-epidemiológicas de pacientes con dengue con signos de alarma, Región Tumbes 2018-2022”¹⁴. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y descriptivo, que contó con una muestra de 112 casos, a la que se le aplicó una ficha documental como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que las características con más prevalencia fueron la edad adulta, el sexo femenino, la procedencia urbana, la falta de antecedente de dengue. Los signos de alarma más comunes fueron el dolor abdominal, el vómito y el aumento de hematocrito. Al respecto, se puede concluir que se pudo caracterizar un cuadro clínico-epidemiológico de pacientes de Tumbes, lo que puede contribuir a la mejor atención¹⁴.

Luque et al. (2023) realizaron una investigación, titulada “Características clínicas y epidemiológicas de las muertes por dengue durante un brote en el norte del Perú”, la cual tuvo como objetivo “Describir las características de los pacientes fallecidos por dengue grave durante el fenómeno de El Niño del 2017 en Piura”¹⁵. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y descriptivo, que contó con una muestra de 24 casos, a la que se le aplicó una ficha documental como

instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que las características epidemiológicas más comunes fueron el sexo femenino, el no tener comorbilidad, con dengue previo y dengue severo; mientras que las características clínicas más comunes fueron la fiebre, las náuseas y vómitos, el dolor abdominal, el malestar general, la artralgia y el dolor de cabeza. Al respecto, se puede concluir que “la mortalidad del dengue grave fue mayoritaria en las mujeres adultas y el tiempo de atención desde el primer establecimiento de salud hasta una unidad especializada fue prolongada”¹⁵.

Domínguez (2023) realizó una investigación, titulada “Factores asociados a dengue con signos de alarma en pacientes del Hospital Apoyo Chepén durante alerta epidemiológica, 2023”, la cual tuvo como objetivo “determinar los factores asociados a dengue con signos de alarma en pacientes del Hospital de Apoyo de Chepén durante los meses de abril a julio del año 2023”¹⁶. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y correlacional, que contó con una muestra de 132 casos, a la que se le aplicó una ficha documental como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que vivir en zona tropical incide en tener signos de alarma, pero no se encontró relación con las otras variables, como reinfección, sexo, HTA, obesidad o diabetes. Al respecto, se puede concluir que los signos de alarma van a depender de la zona geográfica de residencia¹⁶.

Núñez y Ortiz (2023) realizaron una investigación, titulada “Factores asociados para desarrollo de dengue grave en pacientes hospitalizados por dengue con signos de alarma en el hospital de Apoyo II - Sullana 2023”,

la cual tuvo como objetivo “identificar los factores asociados en pacientes hospitalizados por dengue con signos de alarma que se relacionan con el desarrollo de dengue grave en Hospital de apoyo II, SULLANA 2023”¹⁷. En cuanto a su metodología, se trató de un estudio cuantitativo, básico, no experimental y correlacional, que contó con una muestra de 37 casos y 661 controles, a la que se le aplicó una ficha documental como instrumento de recolección de datos. Los resultados indican que se asocian a dengue grave, la HTA, el dolor de cabeza, la mialgia, el prurito, la ginecorragia, el estado mental alterado, la disnea y el aumento del hematocrito y la disminución de las plaquetas. Al respecto, se puede concluir que el desarrollo del dengue grave puede deberse a muchos factores en interacción, por lo cual es necesario estudiar el cuadro clínico-epidemiológico con mayor profundidad¹⁷.

2.2.Bases teóricas

2.2.1. Dengue

Se trata de una infección que puede afectar a personas desde los 0 años en adelante, y que es producida por el virus del dengue, siguiendo patrones estacionales, de mayor incidencia en el primer semestre en el hemisferio sur, y en el segundo semestre en el hemisferio norte, por tratarse de los periodos de mayor calor, que beneficia la reproducción y propagación del vector^{8,10,18}.

Como se puede entender, en América Latina y el Caribe, particularmente los países ubicados en la franja tropical, ha sido un foco principal de dengue en las últimas décadas y esta es una realidad que no parece

atenuarse. Al respecto, autores como Silveira et al.¹⁹ plantean que esto puede deberse, entre otros factores, a las limitaciones económicas de los gobiernos de la región para hacer frente a los mecanismos de control de la propagación, respuesta a epidemias, manejo ecológico, ambiental y social, además de cierto grado de ineficiencia en la gestión de políticas públicas.

Al respecto, un estudio de Tía et al.²⁰, en el rango de 2000 a 2018 observó que los aumentos de prevalencia de dengue en Perú han estado relacionados a los aumentos de temperatura y los efectos de El Niño-Oscilación del Sur, en interacción con la región natural y las estaciones. Esto lleva a que en ciudades como Lima, Ica, Piura o Cusco tengan demarcadas diferencias entre invierno y verano, con prevalencia mayor en verano, mientras que en regiones como San Martín, Amazonas o Pasco, la prevalencia se mantiene más constante a lo largo del año. En el caso de la epidemia de dengue sufrida en Perú desde 2023, se toma como una de las causas principales, además de lo anterior, las inundaciones dejadas por el ciclón Yaku a inicios de marzo²¹, aunque se entiende que el mismo no cambió el perfil clínico-epidemiológico²².

Esta epidemia se considera el más devastador rebrote de dengue en toda la historia de Perú, y hay evidencia de que todavía no se ha detenido. Según Maguiña et al.²³, la tormenta perfecta que generó las condiciones para un rebrote tan potente fueron, entre las ya nombradas, el fenómeno del cambio climático, el deterioro de las condiciones vitales de la población, sobre todo de la pobre y la resistencia progresiva del vector a algunas sustancias usadas para su control. Por otra parte, León et al.²⁴ alertan sobre errores frecuentes tanto en el tratamiento como en el diagnóstico del dengue con

signos de alarma y dengue grave, incluso antes del rebrote del 2023, lo que podría multiplicarse en situación de epidemia, por la sobrecarga laboral y la necesidad de más personal sanitario con menos capacitación. Este fenómeno podría ser el responsable de un ratio de muertes por cantidad de habitantes tan elevados en comparación con los de otros países de la región.

Este virus califica como un arbovirus (es decir, un virus que transmite un artrópodo), perteneciente al género *Flavivirus* (lo que implica que es un virus ARN) y a la familia *Flaviviridae*^{3,11,19}. Se divide en cuatro serotipos, denominados con el acrónimo DENV seguido de un guion y un número del 1 al 4^{2,10,18,25}. Actualmente, se estudia la existencia de un posible quinto serotipo, pero no hay acuerdo en la comunidad académica al respecto¹⁹. Cuando una persona es infectada con cualquiera de estos serotipos adquiere inmunidad vitalicia contra este, pero solo inmunidad breve contra los otros, por lo cual puede desarrollar de nuevo dengue si se infecta con otro serotipo²⁶.

Al respecto, se ha observado que las formas graves o con signos de alarma de la infección son más comunes cuando el sujeto ha tenido una infección previa con otro serotipo^{18,19}. Sin embargo, al compartir estructura y patogenia es posible que cualquier serotipo produzca las manifestaciones de gravedad, si bien estas se asocian más a las infecciones con los serotipos DENV-2 y DENV-3, que por ende también se asocian a una mortalidad mayor^{10,18}. Por otro lado, es importante destacar que la mayoría de los casos son asintomáticos, seguidos en cantidad por los casos con sintomatología leve, muy parecida a la gripe, caracterizada por fiebre,

cefalea con dolor ocular, dolor muscular y articular, erupción en la piel, vómitos y náuseas^{3,8,25}. Finalmente, “la respuesta clínica del dengue estará determinada por las características virales, estado inmunológico del huésped, composición genética y condiciones epidemiológicas”²⁵.

El vector de esta enfermedad son los mosquitos infectados por el mencionado virus, siendo el más común de estos el *Aedes aegypti* (también denominado *A. aegypti*)^{1,19}. Por su relación con el dengue, a este mosquito también se le conoce como mosquito del dengue, pero este también sirve de vector para otras enfermedades, entre ellas la chikunguña, la fiebre amarilla, el Zika y el virus mayaro^{11,19}. Otros nombres con los que se le denomina es mosquito momia o zancudo patas blancas, por sus características marcas blancas. Otro mosquito que puede transmitir el virus del dengue es el *Aedes albopictus*, también conocido como mosquito tigre, pues también tiene marcas blancas, en este caso principalmente en abdomen y tórax. En algunas zonas, este ha logrado desplazar, parcial o totalmente, al *A. aegypti*^{3,19}.

La infección por dengue suele durar un rango de tres días a dos semanas, con un cuadro que puede atravesar tres fases^{25,26}. La primera sería la etapa febril, que puede durar los primeros cinco días, donde además de la mencionada fiebre, se puede presentar malestar general, cefalea con dolor de ojos, eritema y dolor articular. En niños pequeños durante esta fase, la fiebre podría generar convulsión o algún desorden neurológico. La segunda sería la etapa crítica, que iría del quinto al séptimo día, donde habría una caída de la fiebre y una sensación de que se mejora, pero es justo aquí donde podrían empezar a presentarse los signos de alarma o de

gravedad, por lo cual es fundamental continuar con la hidratación y el descanso. Si se presenta un signo de alarma o gravedad se debe asistir inmediatamente a los servicios médicos. Finalmente, la tercera sería la etapa de recuperación, que se da tras el séptimo día, si no hay síntomas de alarma o gravedad. Aquí mejora el cuadro general y se puede retomar la vida convencional^{3,8,10,25,27}.

A la fecha, todavía no se ha desarrollado una vacuna de probada eficiencia contra el virus, estando el desarrollo de vacunas tetravalentes (que ataquen a los cuatro serotipos del virus) en fase de pruebas¹⁹. De la misma forma, una vez infectado el sujeto no existe un tratamiento curativo, sino solamente paliativo, para reducir el impacto sintomático y evitar que la condición agrave, lo mismo que la muerte. En ese sentido, se han establecido tres grupos terapéuticos³.

El grupo A: dengue sin signos de alarma; está destinado al cuidado en el hogar, pues no hay señales de alerta o gravedad. Se reduce a un consumo mayor de líquidos para controlar la deshidratación, evitar la aspirina y los AINE y el uso de paracetamol para controlar la fiebre y el dolor. El grupo B: dengue con signos de alarma; está destinado a los infectados con signos de alarma o factores de riesgo asociados. A estos se les suele hospitalizar por un mínimo de 3 días para hidratación endovenosa, lo mismo que para monitorear los signos vitales, el gasto urinario y la fluctuación del hematocrito. Finalmente, el grupo C: dengue grave; es para los pacientes con manifestaciones de gravedad, que son internados en UCI, donde se les atiende en función de la gravedad y los síntomas^{10,26}.

Debido a la falta de vacuna o cura, el mejor control sanitario se puede conseguir por medio de la prevención, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud implica tanto prevenir la infección, como atenuar los factores de riesgo poblacionales, ecológicos, sociales, entre otros, y evitar el avance del contagio, reduciendo al mínimo las consecuencias negativas. Para esto es necesario el trabajo coordinado y conjunto de gobiernos, comunidad, leyes sanitarias y la coordinación intersectorial^{3,10,18,19}.

Algunas de las medidas preventivas más importantes serían procurar que los hogares y áreas comunitarias estén ordenadas, limpias, sin basura acumulada y sin objetos que puedan almacenar agua estancada. También el uso de insecticidas, repelentes, ropa protectora, mosquiteros y afines, que mantengan alejados a los mosquitos. Y mantener a las comunidades informadas y sensibilizadas sobre su rol en la prevención, estableciendo grupos de vigilancia activa sobre la aparición de vectores en una comunidad^{3,10,18}.

2.2.1.1. Características epidemiológicas del dengue

Las características epidemiológicas de una infección, en este caso del dengue, son aquellas que pueden hacer más o menos propensa a una persona, comunidad o región a recibir la misma. Esto es así porque ciertas características de las personas, comunidades o regiones se consideran factores de riesgo para la adquisición de ciertas enfermedades, mientras que otras se consideran factores de protección¹⁸. A continuación, se listan y explican algunas de las características epidemiológicas que podrían ser de interés en el estudio y prevención del dengue.

Sexo: Se refiere a la división de la población en sexo masculino y femenino. En el caso del dengue, no hay un consenso establecido sobre a cuál sexo afecta más, pero algunos estudios han encontrado evidencia de que podría ser el sexo femenino²⁸.

Edad: Se refiere a la división de la población de acuerdo a sus periodos vitales, como niño, adolescente, adulto o adulto mayor. En el caso del dengue, los estudios no son conclusivos sobre cuál rango de edad esté más afectado, e incluso se ha visto que podría haber ido cambiado a lo largo de los años²⁹.

Antecedente de Dengue: Se refiere a la división de la población entre aquello que han tenido dengue al menos una vez en el pasado y aquellos que no. Si bien tener dengue en una ocasión genera inmunidad vitalicia para el serotipo que generó la infección, también aumenta la probabilidad de padecer dengue con signos de alarma o severidad en caso de una reinfección con otro serotipo³⁰.

Tipo de población: Se refiere a la división de la población de acuerdo a si su lugar de residencia tiene características rurales o urbanas. En cuanto al dengue, si bien en su origen afectaba más a las poblaciones rurales, estudios más recientes parecen apuntar a que se está haciendo más frecuente en poblaciones urbanas³¹.

También se ha visto que otras características epidemiológicas que podrían incidir en una mayor probabilidad de ser infectado con dengue, como sería la comorbilidad, el mes de contagio, entre

otros, como un bajo grado de instrucción, en general, y un bajo grado de conocimiento sobre el dengue y su prevención, pues esto lleva a no tomar medidas adecuadas durante fases de brote o epidemia. De la misma forma, algunas ocupaciones podrían estar vinculadas a la infección con dengue, bien porque implican mucho tiempo en casa (como amas de casa o trabajadores remotos) o porque requieren contacto con fuentes de contagio (como recolectores de basura, personal sanitario o campesinos)¹⁰.

En cuanto a los factores ecológicos o naturales, se considera que habitar en zonas con climas húmedos y cálidos puede contribuir a un mayor riesgo de contagio. De allí que la mayoría de contagios ocurran durante la estación de verano o en regiones con clima cálido durante todo el año. De allí también la importancia que tiene el fenómeno del calentamiento global en una mayor incidencia del dengue. En general, se encuentran más propensas las regiones tropicales y en segunda instancia las subtropicales^{3,4,9,20}.

2.2.1.2. Características clínicas del dengue

Las características clínicas del dengue difieren según si este es clásico, con signos de alarma o de severidad. Este cuadro clínico se presenta principalmente durante la etapa febril de la infección, por lo cual debe entenderse que la fiebre, caracterizada por una temperatura corporal superior a 38 °C es el rasgo clínico principal de la condición^{10,18,25,27}. A continuación, se explican algunas de

las características clínicas más comunes del dengue **sin síntomas de alarma:**

Artralgias: Se refiere al dolor en las articulaciones, que puede variar en duración e intensidad, pero que habitualmente es fuerte, razón por la cual al dengue se le conoce como la fiebre rompehuesos³².

Mialgias: Se refiere al dolor en los músculos, pudiendo también afectar a los ligamentos, los tendones y las fascias. Puede estar afectado un solo grupo muscular o todo el cuerpo, de nuevo, en variados niveles de intensidad³³.

Cefalea: Se refiere al dolor en cualquier parte de la cabeza, pero en el dengue la cefalea suele ser principalmente en el área frontal y el área retro-ocular. El dolor suele ser descrito como intenso³⁴.

Dolor ocular: Se refiere a un tipo de cefalea en la cual se experimenta dolor en la parte trasera de los ojos. Puede ocurrir por separado o con otros tipos de dolores de cabeza³⁴.

Erupción cutánea: También conocido como exantema, petequia o sarpullido, se indica cuando, de forma abrupta, aparece diseminada en un área localizada de la piel (por lo general, tórax o extremidades inferiores) o en toda esta lesiones habitualmente de color rojizo brillante y puntiformes, con o sin sensación de prurito³⁵.

Otras características clínicas del dengue sin signos de alarma serían la fiebre, el dolor lumbar, la falta de apetito, el dolor de

garganta y las náuseas, entre otros. Así pues, como se indicó anteriormente, las características clínicas pueden variar en función de si se presentan signos de alarma o gravedad. En ese sentido, a continuación, se mencionan algunas de las características clínicas más comunes propias del dengue **con signos de alarma**.

Sangrado: En el dengue pueden presentarse múltiples manifestaciones de sangrado. Se mencionan algunas: sangre en la orina o en las heces, vómito con sangre o esputo, hemorragia transvaginal, de la nariz, de las encías (estas dos últimas pueden ser signo de un colapso circulatorio inminente), equimosis, entre otros³⁶.

Dolor abdominal: Tal como su nombre lo indica, se refiere a un dolor en la región abdominal que persiste más de un día y de forma intensa. El mismo puede cursar con gastritis o estreñimiento, con hepatitis reactiva o bien con inflamación del bazo o del riñón. Cuando el abdomen se encuentra distendido podría ser un factor de riesgo para un colapso circulatorio inminente³⁷.

Hipotermia: Se refiere a una reducción drástica de la temperatura corporal entre 1 y 2 °C debajo de la norma, que suele ubicarse entre los 36.5 y los 37.5 °C. Esto suele generar escalofríos intensos o severos y sensación de entumecimiento o confusión. Esto puede ser signo de un colapso circulatorio inminente cuando

hay palidez exagerada y tanto pies como manos se sienten muy fríos al tacto³⁸.

Vómitos persistentes: También conocido como emesis, se refiere a la presencia de vómitos varias veces al día por más de un día. Esta puede cursar, también, con náuseas continuas, tanto antes del vómito como por largos periodos en el día. Este síntoma puede conducir muy rápidamente a la deshidratación³⁹.

Disnea: Se refiere a la dificultad para respirar, que el paciente suele describir como una sensación de tener poco aire, que se puede presentar, principalmente, como disnea de esfuerzo, cuando la persona se agita, pero también puede llegar a la forma de disnea de reposo, donde el síntoma persiste aunque no se realice ningún esfuerzo⁴⁰.

Otros signos de alarma serían las petequias, el estado mental alterado, el decaimiento excesivo o lipotimia, el pulso rápido y débil, la hipotensión arterial, entre otros¹⁸.

Finalmente, es posible que se presenten características clínicas propias de un cuadro de dengue grave, que puede producir síndrome de choque, que puede generar la muerte en 2 de cada 10 pacientes afectados. También se puede generar un dengue grave por distrés respiratorio, por hemorragias intensas y espontáneas y por afectación de los órganos (en este caso, se puede producir una hepatopatía severa, o bien miocarditis o encefalitis por dengue)^{10,18}. Así pues, algunos de los signos de choque o de

dengue grave pueden ser las manos o pies extremadamente fríos o cianóticos, un llenado capilar mayor a 2 segundos o una puntuación baja en la Escala de Glasgow, entre otros.

3. METODOLOGÍA

3.1.Método de investigación

Esta investigación se ubica en el método deductivo, mismo que “se basa en hallar datos desconocidos a partir de los datos ya conocidos; en ese sentido, los datos descubiertos de forma general se pueden inferir de la misma forma para los datos particulares o específicos”⁴¹. En ese sentido, se partirá de las teorías ya conocidas acerca de las características epidemiológicas-clínicas del dengue, para poder observar las mismas en una población concreta.

3.2.Enfoque de la investigación

El enfoque de esta investigación es cuantitativo. De acuerdo a Frey ⁴², “los estudios de investigación cuantitativa producen resultados que pueden utilizarse para describir o anotar cambios numéricos en características mensurables de una población de interés; generalizar a otras situaciones similares; proporcionar explicaciones de predicciones; y explicar relaciones causales”. De esta forma, en esta investigación se hará uso de estadísticos descriptivos para valorar la frecuencia en la que se presentan las características epidemiológicas-clínicas a estudiar en la muestra.

3.3.Tipo de investigación

El propósito de esta investigación es puro. Esta tipología de investigación “se encuentra enfocada a generar nuevos conocimientos más completos a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos y de los hechos observables”⁴³. Es así que se producirán conocimientos contextuales sobre las

características epidemiológicas-clínicas de una muestra específica de pacientes con dengue.

Por su parte, el nivel de esta investigación es descriptivo. Toda investigación descriptiva “intenta describir o definir un tema, a menudo creando un perfil de un grupo de problemas, personas o eventos, a través de la recopilación de datos y la tabulación de las frecuencias en variables de investigación o su interacción”⁴⁴. Ello se observará en el presente estudio, en la elaboración de tablas de frecuencia acerca de las características epidemiológicas-clínicas de la muestra.

Para finalizar, el manejo de la data será documental. La investigación de tipo documental “se realiza mediante la consulta de los documentos (...). En este tipo de investigación se indagan sobre libros, revistas, periódicos, registros, la constitución, etc.”⁴¹. Para el caso particular de este trabajo, se tabulará la data derivada de las historias clínicas y las fichas epidemiológicas del establecimiento sanitario.

3.4.Diseño de investigación

En cuanto a la temporalidad, el diseño de este estudio es retrospectivo. Según Frey ⁴², “en un estudio retrospectivo, a diferencia de un estudio prospectivo, el resultado de interés ya se ha producido en el momento en que se inicia el estudio”. Eso quiere decir que se tomará la data histórica del año 2023. Por otra parte, según el número de mediciones, se considera un estudio de diseño transversal. Según Pérez et al. ⁴⁵, en este diseño se toman “los datos una sola vez y los resultados (...) serán válidos para explicar el estado de situación en ese momento específico”. Así pues, se tomará en cuenta el estado del paciente en su primera atención por motivo

de dengue, sin tomar en cuenta las eventuales atenciones de seguimiento que haya recibido.

Sobre el grado de experimentación, el presente estudio califica como no experimental. Este diseño de investigación “se realiza sin manipular deliberadamente variables (...). Lo que efectúas en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural, para analizarlas”⁴³. En ese sentido, para este estudio los valores a tomar en consideración de la muestra no serán alterados, sino que se tomarán tal cual como se encuentren en la base documental. Por último, este estudio califica dentro del diseño específico descriptivo, concepto que no difiere del explicado en el nivel de la investigación.

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población

Se puede definir a la población como “el conjunto de sujetos, objetos o cosas con una característica o atributo especial, los cuales son tomados en su totalidad”⁴⁶. Para este caso, la población estará compuesta por los pacientes con diagnóstico de dengue, atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima durante el año 2023, a saber, un total de 140 sujetos, número que se tomará como población del presente estudio.

3.5.2. Muestreo

El tipo de muestreo utilizado en este estudio fue el muestreo probabilístico aleatorio simple o MAS, mismo que según Pérez et al. ⁴⁵, se calcula tomando en cuenta lo siguiente: “dada una población de tamaño N, consideramos todas las muestras posibles de tamaño n. En el muestreo

aleatorio simple, cada una de estas muestras, de las cuales el número total viene dado por el combinatorio $C(N, n)$, al ser del mismo tamaño, debe tener la misma probabilidad”. Esto se traduce en la fórmula a continuación:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

Donde:

N = tamaño de la población.

Z = nivel de confianza.

P = probabilidad de éxito.

Q = probabilidad de fracaso.

D = Margen de error.

3.5.3. Muestra

Para la aplicación del MAS, se consideraron como valores un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 5% y heterogeneidad de 50%, determinada por la probabilidad de éxito y fracaso. Una vez aplicados estos valores, la muestra a desarrollar para lograr la representatividad de la población se determinó en un tamaño de 103 pacientes con dengue.

3.6.Variable y operacionalización

3.6.1. Variable

Variable 1: Características epidemiológicas-clínicas

Variable 2: Dengue

3.6.2. Operacionalización de la variable

Ver Tabla 1 (p. 36).

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnicas

El análisis documental será la técnica a aplicar en la presente investigación. Este se refiere al “análisis de los contenidos de las fuentes documentales mediante una operación intelectual que consiste en extraer de un documento los elementos de información más significativos desde la perspectiva del investigador”⁴⁷. Para su aplicación, se recolectarán los datos de las historias clínicas y fichas de investigación clínico epidemiológicas de los pacientes con dengue de la muestra.

3.7.2. Descripción de instrumentos

La ficha documental será el instrumento a aplicar en la presente investigación. Esta implica tabular de forma física o digital la data sacada de cada fuente documental, una vez completada su depuración o preparación según las necesidades de la investigación⁴⁸. La ficha documental que se usará en este estudio se encuentra en el Anexo 2, y el formato de validación por juicio de expertos se encuentra en el Anexo 3.

La validación por juicio de expertos fue realizada por 3 expertos en el área de investigación, misma que se puede observar en el Anexo 4. Una vez aplicada la primera validación y modificado el instrumento en función de las recomendaciones de los expertos, se obtiene un coeficiente V de Aiken de 0.99, con lo cual se considera que el mencionado instrumento es válido.

Tabla 1

Matriz de operacionalización de la variable

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Valores	Tipo de variable
Variable 1: Características epidemiológicas-clínicas	Las características clínicas del dengue se refieren al cuadro sintomático si este es clásico, con signos de alarma o de severidad, siendo el principal síntoma la fiebre. Por su parte, las características epidemiológicas del dengue son aquellas que pueden hacer más o menos propensa a una persona, comunidad o región a recibir dicha infección (10,18).	Sexo: División de la población en sexo masculino y femenino.	•Características epidemiológicas.	•Sexo.	• Masculino • Femenino	Nominal.
		Edad: categorizado según etapas de vida.		•Edad.	•Niño •Adolescente •Adulto •Adulto mayor	Ordinal.
		Antecedente de dengue: división de población si ha tenido dengue al menos una vez en el pasado.		•Antecedente de dengue.	•Presencia. •Ausencia.	Nominal.
		Hospitalizado: paciente hospitalizado por antecedente de dengue.		•Hospitalizado.	•Presencia. •Ausencia.	Nominal
		Cormobilidades: presencia de uno o más patologías frecuentes en la población.		•Comorbilidades.	•Hipertensión arterial. •Diabetes Mellitus. •Enf. renal crónica. •Hipotiroidismo. •Otros. •Ninguno.	Nominal.
		Tipo de población: Se divide de acuerdo a su lugar de residencia.		•Tipo de población.	•Urbana. •Rural.	Nominal
		Mes de contagio: periodo de tiempo de mayor contagio en la población.		•Mes de contagio	• Enero. • Febrero. • Marzo. • Abril. • Mayo. • Junio. • Julio. • Agosto. • Septiembre. • Octubre. • Noviembre. • Diciembre.	Ordinal.

		Temperatura: categoría de temperatura corporal.	• Características clínicas.	• Temperatura.	• Hipotermia. • Normal. • Febrícula. • Fiebre. • Hipertermia.	Ordinal.
		Escala de Glasgow: sistema de puntuación que evalúa nivel de conciencia.		• Escala de Glasgow.	• Leve. • Moderado. • Severo.	Ordinal.
		Signos y síntomas de cuadro sintomático clásico.		• Signos y síntomas	• Fiebre. • Artralgias. • Mialgias. • Cefalea. • Dolor retroocular. • Dolor lumbar. • Rash cutánea. • Escalofríos. • Falta de apetito. • Náuseas.	Nominal.
		Señales de alarma: signos y síntomas de señales de signo de gravedad.		• Señales de alarma.	• Epistaxis. • Gingivorragia. • Dolor Abdominal persistente. • Disminución de la diuresis. • Vómitos persistentes. • Hepatomegalia. • Estado mental alterado • Disnea. • Pulso rápido y débil. • Hipotensión arterial.	Nominal.
Variable 2: Dengue	Se trata de una infección que puede afectar a personas desde los 0 años en adelante, que se transmite a través de la picadura del mosquito " <i>Aedes Aegypti</i> " (1,10,18,26).	Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y presenta fiebre de 2 a 7 días de evolución; y 2 o más signos y síntomas.	• Dengue sin señales de alarma	• Sin señales de alarma	• Si. • No.	Nominal.
		Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta 1 o más señales de alarma.	• Dengue con señales de alarma	• Con señales de alarma	• Si. • No.	Nominal

Referencias: 1, 10, 18,26

Fuente: Elaboración propia

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Ya recogida la información, esta será procesada con los programas informáticos Excel y SPSS, en los cuales se tabulará la información y se aplicarán los estadísticos descriptivos, principalmente por medio de tablas de frecuencia. Según Hernández-Sampieri y Mendoza ⁴⁸, el análisis descriptivo “implica el conteo de casos que se presentaron en las categorías de las variables con el propósito de conocer tendencias”, mientras que la distribución de frecuencias, según Frey ⁴², “muestra todas las puntuaciones posibles que ha tomado una variable en un conjunto concreto de datos, junto con la frecuencia de aparición de cada puntuación en el conjunto respectivo”.

3.9. Aspectos éticos

En la medida de que no se recogerá información de manera prospectiva, directamente con los pacientes, y que la misma ya se encuentra en las bases de datos del centro de salud, de las cuales solo se tomarán los datos clínicos de interés, manteniendo los demás datos sensibles confidenciales, no es necesario recolectar ninguna forma de consentimiento informado, pero la investigadora se compromete a proteger la integridad de la información y a las personas identificables por medio de esta. Para ello, cada paciente será identificado con un código numérico único, y el resto de la base de datos del centro de salud será devuelto a este, de modo que la información permanezca protegida. En ese mismo espíritu, toda información proveniente de las mencionadas bases de datos será transcrita de manera fidedigna, sin adulterar, y los resultados estadísticos derivados del análisis serán presentados tal como los que entreguen los softwares de análisis utilizados. Por último, la autora del presente trabajo da fe de haber

respetado a la comunidad académica al manifestar con claridad y precisión cuáles son los textos y autores que han servido como referencia para el desarrollo de las diferentes secciones de este documento, haciendo un uso prudente y respetuoso de recursos como la citación textual y la paráfrasis en donde correspondiera.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.Cronograma de actividades

Ver Tabla 2.

Tabla 2

Cronograma de actividades

#	Actividades a realizar (enero a septiembre de 2024)	2024										
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
1	Recopilación de material bibliográfico a investigar											
2	Planteamiento del problema											
3	Marco teórico de la investigación											
4	Hipótesis, variables e instrumento											
5	Metodología de la investigación y administración de la investigación											
6	Inscripción del proyecto de investigación											
7	Revisión y aprobación del proyecto de tesis											
8	Presentación al área de investigación de la DIRIS Lima Centro para el permiso de ejecución del proyecto en el C.S.											
9	Aplicación de técnicas de recolección de datos											
10	Tabulación de resultados de recolección de datos											
11	Redacción del informe final											
12	Inscripción de la tesis											
13	Revisión y aprobación de la tesis											
14	Sustentación de la tesis											

4.2.Presupuesto

Ver Tabla 3 (p. 41).

Tabla 3

Presupuesto

Detalles	Cantidad	Precio unitario	Total
Recursos humanos			
• Digitador estadístico	1	S/. 700.00	S/. 700.00
Subtotal	1	S/. 700.00	S/. 700.00
Recursos materiales			
• Memoria USB	2	S/. 30.00	S/. 60.00
• Papel (millar)	2	S/. 22.00	S/. 44.00
• Lapiceros	5	S/. 2.00	S/. 10.00
• Libreta de apuntes.	3	S/. 4.00	S/. 12.00
• Resaltador	4	S/. 3.00	S/. 12.00
• Sobre	4	S/. 1.00	S/. 4.00
Subtotal	20	S/. 62.00	S/. 142.00
Físicos – servicios			
• Copias	N/A	S/. 150.00	S/. 150.00
• Empaste	N/A	S/. 200.00	S/. 200.00
• Impresiones	N/A	S/. 400.00	S/. 400.00
• Anillados	N/A	S/. 50.00	S/. 50.00
• Internet	N/A	S/. 280.00	S/. 280.00
• Transporte	N/A	S/. 300.00	S/. 300.00
Subtotal	N/A	S/. 1,380.00	S/. 1,380.00
Total general	N/A	S/. 2,142.00	S/. 2,222.00

5. REFERENCIAS

1. WHO. Dengue and severe dengue [Internet]. 2023 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>
2. Yang X, Quam M, Zhang T, Sang S. Global burden for dengue and the evolving pattern in the past 30 years. J Travel Med [Internet]. 2021; 28(8): 1-11. [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jtm/taab146>
3. Kularatne SA, Dalugama C. Dengue infection: Global importance, immunopathology and management. Clinical Medicine [Internet]. 2022; 22(1): 9–13 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0791>
4. Torres-Signes A, Dip JA. A Bayesian Functional Methodology for Dengue Risk Mapping in Latin America and the Caribbean. Acta Trop [Internet]. 2021; 215:105788 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105788>
5. Ranking de los 20 países de América Latina con mayor número de casos de dengue reportados desde 1980 hasta el enero de 2024 [Internet]. Statista. 2024 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1377218/ranking-de-paises-con-mas-infecciones-por-dengue/>
6. Florencia M. El dengue en Latinoamérica [Internet]. Statista. 2024 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en:

<https://es.statista.com/grafico/31701/cantidad-de-casos-y-muertes-por-dengue-y-dengue-grave-latinoamerica/>

7. Ministerio de Salud. Sala situacional de Dengue [Internet]. MINSA. 2024 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/sala-situacional-dengue/#grafico01>
8. Estrada E, Trujillo M, Molina A, Llamuca B. Características epidemiológicas del dengue en el Ecuador – año 2022. Revisión bibliográfica. LATAM [Internet]. 2024; 5(1): 2134–2149. [citado el 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1732>
9. García L, Oliveros W, Sotaban L, Velasco J. Caracterización clínica y epidemiológica del dengue 2015-2020 Hospital Regional de la Orinoquía ESE. Rev Ces Med [Internet]. 2023; 37(1): 1–11. [citado el 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.21615/cesmedicina.6890>
10. Silverio-Calderón C. Dengue: actualidades, características clínicas epidemiológicas y prevención. RCS [Internet]. 2023; 6(11): 2–17. [citado el 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://journalgestar.org/index.php/gestar/article/view/80>
11. Ricardo-Rivera S, Aldana-Carrasco L, Lozada-Martinez I, Bolaño-Romero M, Acevedo-Lopez N, Sajona-Leguia W, et al. Mapping Dengue in children in a Colombian Caribbean Region: clinical and epidemiological analysis of more than 3500 cases. Le infezioni in medicina [Internet]. 2022; 30(4): 602–609. [citado el 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.53854/liim-3004-16>
12. Cazes C, Carballo C, Praino M, Ferolla F, Mistchenko A, Contrini M, et al. Brote epidémico de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, 2016: características clínicas

- y hematológicas de la infección en una población pediátrica. Arch Argent Pediatr [Internet]. 2019; 117(1): e63–e67. [citado el 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2019.e63>
13. Valverde P, Muñoz J. Características clínicas y epidemiológicas en pacientes adultos mayores con dengue en un establecimiento de salud I-4, Lambayeque 2023. [Tesis de grado]. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2024.
Disponible en: <https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/12711>
 14. Alcántara P. Características clínico-epidemiológicas de pacientes con dengue con signos de alarma - Región Tumbes 2018-2022. [Tesis de grado]. Tumbes: Universidad Nacional de Tumbes; 2023. Disponible en: <https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64749>
 15. Luque N, Cilloniz C, Pons M, Donaires F, Albornoz R, Mendocilla-Risco M, et al. Características clínicas y epidemiológicas de las muertes por dengue durante un brote en el norte del Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2023; 40(1): 67–72 [citado el 19 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2023.401.12148>
 16. Domínguez E. Factores asociados a dengue con signos de alarma en pacientes del Hospital Apoyo Chepén durante alerta epidemiológica, 2023 [Tesis de grado]. Trujillo: Universidad César Vallejo; 2023. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/131780>
 17. Núñez J, Ortiz M. Factores asociados para desarrollo de dengue grave en pacientes hospitalizados por dengue con signos de alarma en el hospital de Apoyo II -

- Sullana 2023 [Tesis de grado]. Piura: Universidad César Vallejo; 2023.
Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/132088>
18. Nieto P, Andrade J, Colcha M, Andrade C, Galarza E, Fernández L. Dengue: actualidades, características clínicas epidemiológica y prevención. *Revista Sanitaria de Investigación* [Internet]. 2023; 4(4). [citado el 20 de marzo de 2024].
Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8930922>
 19. Silveira C, Saraiva K, de Souza M, Souza B. Dengue as a Disease Threatening Global Health: A Narrative Review Focusing on Latin America and Brazil. *Trop Med Infect Dis* [Internet]. 2023; 8(5): 241 [citado el 12 de marzo de 2024].
Disponible en: <https://doi.org/10.3390/tropicalmed8050241>
 20. Dostal T, Meisner J, Munayco C, García P, Cárcamo C, Pérez J, et al. The effect of weather and climate on dengue outbreak risk in Peru, 2000-2018: A time-series analysis. *PLoS Negl Trop Dis* [Internet]. 2022; 16(6): 1-18 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010479>
 21. Del Carpio L. El entorno ecológico y climático favorece a los arbovirus, ciclón Yaku y el dengue en Perú. *Norte Médico* [Internet]. 2023; 2(6):18–19 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.pe/index.php/nortemedico/article/view/149>
 22. Ordóñez G. Perfil clínico-epidemiológico durante el ciclón Yaku asociado a la incidencia del dengue en un hospital de Trujillo, 2023. [Tesis de grado]. Trujillo: Universidad César Vallejo; 2023. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/132028>

23. Maguiña Vargas C. El brote de dengue en Perú: Análisis y perspectivas. *Acta Méd Peru* [Internet]. 2023; 40(2):87–90 [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.35663/amp.2023.402.2663>
24. León F, Inga-Chero J, Mendoza-Farro N, Montoya A, Dioses K, Cavalcanti S, et al. Características y errores más frecuentes en el diagnóstico y tratamiento del dengue en un hospital del norte peruano, 2022. *An Fac de Med*. [Internet]. 2023; 84(2): 210–212. [citado el 12 de marzo de 2024]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15381/anales.v84i2.25494>
25. Teruel R, Leyva M, Flores E. Características clínicas y métodos diagnósticos del dengue. *CSSN*. [Internet]. 2022; 12: 100–108. [citado el 20 de marzo de 2024]. Disponible en: <http://revistas.esPOCH.edu.ec/index.php/cssn/article/view/654>
26. PAHO/WHO | Pan American Health Organization [Internet]. Algoritmos para el manejo clínico de los casos de dengue; [consultado el 1 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/algoritmos-para-manejo-clinico-casos-dengue>
27. Rodríguez-Gómez JH. Dengue con signos de alarma. *Rev Salud Amaz Bienestar* [Internet]. 2022; 1(2):e399. [citado el 20 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.51252/rsayb.v1i2.399>
28. Momin A, Manzoor I, Mustafa N, Wajid Z, Siddiqui A, Haleem F, et al. Gender and age based evaluation of clinical signs and symptoms of dengue: A secondary data analysis. *SOJ Microbiol Infect Dis* [Internet]. 2019; 6(1):1–4. [citado el 20 de marzo de 2024]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Ahsan-Siddiqui/publication/331310832_Gender_and_age_based_evaluation_of_clinical_signs_and_symptoms_of_dengue_A_secondary_data_analysis/links/5c722ca8

299bf1268d1ff0a2/Gender-and-age-based-evaluation-of-clinical-signs-and-symptoms-of-dengue-A-secondary-data-analysis.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&_sg%5B1%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail&_rtd=e30%3D

29. Ganegoda N, Götz T, Putra Wijaya K. An age-dependent model for dengue transmission: Analysis and comparison to field data. *Appl Math Comput* [Internet]. 2021; 388:1-21 [citado el 20 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125538>
30. Valencia B, Sigera P, Weeratunga P, Tedla N, Fernando D, Rajapakse S, et al. Effect of prior Zika and dengue virus exposure on the severity of a subsequent dengue infection in adults. *Sci Rep* [Internet]. 2022; 12(1):1-7 [citado el 20 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-22231-y>
31. Yin S, Ren C, Shi Y, Hua J, Yuan HY, Tian LW. A Systematic Review on Modeling Methods and Influential Factors for Mapping Dengue-Related Risk in Urban Settings. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022; 19(22): 1-20 [citado el 20 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph192215265>
32. Wilson R, Chae J. Musculoskeletal Pain. En: Wilson R, Raghavan P, editores. *Stroke Rehabilitation* [Internet]. Elsevier; 2019 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 91–103. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-55381-0.00006-8>
33. Bockman C, Eckerson J, McCarson K. Myalgia. En: *Reference Module in Biomedical Sciences* [Internet]. Elsevier; 2015 [citado el 20 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.05161-8>

34. Lauck S, Gage S. Headaches. En: Kliegman R, Bordoni B, Basel D, Lye P, Toth H, editores. Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis [Internet]. Elsevier; 2018 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 439-454.e1. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-39956-2.00028-5>
35. Warris A, Kroon FP. Viral Exanthems. En: William J, editor. Infectious Diseases [Internet]. Elsevier; 2017 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 75-83.e1. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-6285-8.00009-5>
36. Gubler D. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. En: Guerrant R, Weller P, Walker D, editores. Tropical Infectious Diseases [Internet]. Elsevier; 2006 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 813–22. Disponible en: Guerrant
37. Miranda A. Abdominal Pain. En: Kliegman R, Bordini B, Toth H, Basel D, editores. Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis: Common Diseases and their Mimics [Internet]. Elsevier; 2023 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 222-241.e2. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-76174-1.00013-4>
38. Gelb D. Hypothermia. En: Aminoff M, Daroff R, editores. Encyclopedia of the Neurological Sciences [Internet]. Elsevier; 2014 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 657–8. Disponible en: Aminoff
39. Federle M, Sinha S, Poullos P, editores. Nausea and Vomiting. En: Imaging in Gastroenterology [Internet]. Elsevier; 2018 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 16–9. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-55408-4.50012-4>
40. Binks A. Dyspnea. En: Handbook of Clinical Neurology [Internet]. 2022 [citado el 20 de marzo de 2024]. p. 309–38. Disponible en: Handbook of Clinical Neurology

41. Arias J. Proyecto de tesis. Guía para la elaboración. JLAG; 2020.
42. Frey B, editor. The SAGE Encyclopedia of Research Design. 2°. SAGE; 2022.
43. Arispe CM, Yangali JS, Guerrero MA, Rivera O, Acuña LA, Arellano C. La investigación científica. Una aproximación para los estudios de posgrado. Universidad internacional de Guayaquil; 2020.
44. Noreña D. Diccionario de investigación [Internet]. Universidad de Lima; 2020. Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/10889>
45. Pérez L, Pérez R, Seca M. Metodología de la investigación científica. Maipue; 2020.
46. Santos E, Geraldo L, Tito P. Metodología y herramientas de investigación científica. Atena Editora; 2022.
47. Bernardo C, Carbajal Y, Contreras V. Metodología de la Investigación. Manual del estudiante [Internet]. Universidad De San Martin De Porres. 2019. Disponible en: [https://www.usmp.edu.pe/estudiosgenerales/pdf/2019-I/MANUALES/II CICLO/METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.pdf](https://www.usmp.edu.pe/estudiosgenerales/pdf/2019-I/MANUALES/II%20CICLO/METODOLOGIA%20DE%20LA%20INVESTIGACION.pdf)
48. Hernández-Sampieri R, Mendoza CP. Metodología de la investigación. Las rutas Cuantitativa Cualitativa y Mixta. Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México D.F.: McGraw-Hill; 2018.

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Variable	Diseño metodológico	Instrumento
Problema general: ¿Cuáles son las características epidemiológicas-clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023?	Objetivo general: Determinar cuáles son las características epidemiológicas-clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023.	Variable 1: Características epidemiológicas-clínicas	Tipo de investigación: cuantitativo, puro, descriptivo y documental.	Ficha documental
Problemas específicos: • ¿Cuáles son las características epidemiológicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023? • ¿Cuáles son las características clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023?	Objetivos específicos: • Determinar cuáles son las características epidemiológicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023. • Determinar cuáles son las características clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023.	Dimensiones: 1. Características epidemiológicas. 2. Características clínicas.	Método y diseño de investigación: deductivo, retrospectivo, transversal, no experimental y descriptivo.	
		Variable 2: Dengue	Población y muestra: 140 sujetos a los que se aplicó MAS, para obtener una muestra de 103 pacientes con prueba positiva y diagnóstico de dengue.	
		Dimensiones: 1. Dengue sin señales de alarma. 2. Dengue con señales de alarma.		

Anexo 2. Ficha documental sobre características epidemiológicas-clínicas y signos de alarma en el dengue.

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

OBJETIVO: Determinar cuáles son las características epidemiológicas-clínicas de pacientes con dengue atendidos en el Centro de Salud Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, durante 2023.

CÓDIGO: _____

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS:

SEXO	Femenino ☐ Masculino ☐	EDAD	Niños (< 12 años)	☐		
ANTECEDENTE DE DENGUE	SÍ ☐ NO ☐		Adolescentes (12-17 años)	☐		
HOSPITALIZADO	SÍ ☐ NO ☐		Adultos (18-59 años)	☐		
COMORBILIDADES	☐ Hipertensión arterial ☐ Diabetes Mellitus ☐ Enf. renal crónica ☐ Hipotiroidismo ☐ Otros ☐ Ninguno		Adultos mayores (>59 años)	☐		
		MES DE CONTAGIO	Enero	☐	Febrero	☐
			Marzo	☐	Abril	☐
			Mayo	☐	Junio	☐
			Julio	☐	Agosto	☐
			Septiembre	☐	Octubre	☐
			Noviembre	☐	Diciembre	☐
TIPO DE POBLACIÓN	Urbana ☐ Rural ☐					

DATOS CLÍNICOS:

TEMPERATURA:

- ☐ Hipotermia (< 36.5°C)
☐ Normal (36.5° - 37.5°C)
☐ Febrícula (37.6° - 37.9°C)
☐ Fiebre (>38.0°C)
☐ Hipertermia (>41.0°C)

ESCALA DE GLASGOW:

- ☐ Leve ≥14
☐ Moderado 9 – 13
☐ Severo ≤8

SIGNOS Y SÍNTOMAS		SEÑALES DE ALARMA	
Fiebre	SÍ ☐ NO ☐	Epistaxis	SÍ ☐ NO ☐
Artralgias	SÍ ☐ NO ☐	Gingivorragia	SÍ ☐ NO ☐
Mialgias	SÍ ☐ NO ☐	Dolor Abdominal Persistente	SÍ ☐ NO ☐
Cefalea	SÍ ☐ NO ☐	Disminución de la diuresis	SÍ ☐ NO ☐
Dolor retroocular	SÍ ☐ NO ☐	Vómitos persistentes	SÍ ☐ NO ☐
Dolor lumbar	SÍ ☐ NO ☐	Hepatomegalia	SÍ ☐ NO ☐
Rash cutánea	SÍ ☐ NO ☐	Estado mental alterado	SÍ ☐ NO ☐
Escalofríos	SÍ ☐ NO ☐	Disnea	SÍ ☐ NO ☐
Falta de apetito	SÍ ☐ NO ☐	Pulso rápido y débil	SÍ ☐ NO ☐
Náuseas	SÍ ☐ NO ☐	Hipotensión arterial	SÍ ☐ NO ☐

DIAGNÓSTICO: Dengue sin señales de alarma SÍ ☐ NO ☐

Dengue con señales de alarma SÍ ☐ NO ☐

Anexo 3. Formato de validación del instrumento

CARTA DE PRESENTACIÓN

Dr.:

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y, asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Medicina Humana requiero validar los instrumentos, a fin de recoger información necesaria para desarrollar mi investigación, con la cual optaré al título de Médico Cirujano.

El nombre de mi proyecto de investigación es “Características epidemiológicas-clínicas de pacientes con dengue, Centro de Salud Santa Rosa de Lima, San Juan de Lurigancho, 2023” y, debido a que es imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado convenientemente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de desarrollo de instrumentos de recolección de datos científicos.

El expediente de validación que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole los sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes agradecer por la atención que dispense a la presente.

Atentamente,



Angela Anaya
DNI: 77020966

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable 1: Características epidemiológicas-clínicas

Las características clínicas del dengue se refieren al cuadro sintomático si este es clásico o con signos de alarma, siendo el principal síntoma la fiebre. Por su parte, las características epidemiológicas del dengue son aquellas que pueden hacer más o menos propensa a una persona, comunidad o región a recibir dicha infección.

Dimensiones de la variable:

1. Características epidemiológicas: sexo, edad, antecedente de dengue, hospitalizado, comorbilidades, tipo de población, mes de contagio.
2. Características clínicas: temperatura, escala de glasgow, signos y síntomas (fiebre, artralgias, mialgias, cefalea, dolor retroocular, dolor lumbar, rash cutánea, escalofríos, falta de apetito, náuseas), señales de alarma (epistaxis, gingivorragia, dolor abdominal persistente, disminución de la diuresis, vómitos persistentes, hepatomegalia, estado mental alterado, disnea, pulso rápido y débil, hipotensión arterial).

Variable 2: Dengue

Se trata de una infección que puede afectar a personas desde los 0 años en adelante, que se transmite a través de la picadura del mosquito "*Aedes Aegypti*".

Dimensiones de la variable:

1. **Dengue sin señales de alarma:** Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y presenta fiebre de 2 a 7 días de evolución; y 2 o más signos y síntomas.
2. **Dengue con señales de alarma:** Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta 1 o más señales de alarma.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Valores	Tipo de variable
Variable 1: Características epidemiológicas-clínicas	Las características clínicas del dengue se refieren al cuadro sintomático si este es clásico, con signos de alarma o de severidad, siendo el principal síntoma la fiebre. Por su parte, las características epidemiológicas del dengue son aquellas que pueden hacer más o menos propensa a una persona, comunidad o región a recibir dicha infección (10,18).	Sexo: División de la población en sexo masculino y femenino.	•Características epidemiológicas.	•Sexo.	• Masculino • Femenino	Nominal.
		Edad: categorizado según etapas de vida.		•Edad.	•Niño •Adolescente •Adulto •Adulto mayor	Ordinal.
		Antecedente de dengue: división de población si ha tenido dengue al menos una vez en el pasado.		•Antecedente de dengue.	•Presencia. •Ausencia.	Nominal.
		Hospitalizado: paciente hospitalizado por antecedente de dengue.		•Hospitalizado.	•Presencia. •Ausencia.	Nominal
		Cormobilidades: presencia de uno o más patologías frecuentes en la población.		•Comorbilidades.	•Hipertensión arterial. •Diabetes Mellitus. •Enf. renal crónica. •Hipotiroidismo. •Otros. •Ninguno.	Nominal.
		Tipo de población: Se divide de acuerdo a su lugar de residencia.		•Tipo de población.	•Urbana. •Rural.	Nominal
		Mes de contagio: periodo de tiempo de mayor contagio en la población.		•Mes de contagio	• Enero. • Febrero. • Marzo. • Abril. • Mayo. • Junio. • Julio. • Agosto. • Septiembre. • Octubre. • Noviembre. • Diciembre.	Ordinal.

		Temperatura: categoría de temperatura corporal.	• Características clínicas.	• Temperatura.	• Hipotermia. • Normal. • Febrícula. • Fiebre. • Hipertermia.	Ordinal.
		Escala de Glasgow: sistema de puntuación que evalúa nivel de conciencia.		• Escala de Glasgow.	• Leve. • Moderado. • Severo.	Ordinal.
		Signos y síntomas de cuadro sintomático clásico.		• Signos y síntomas	• Fiebre. • Artralgias. • Mialgias. • Cefalea. • Dolor retroocular. • Dolor lumbar. • Rash cutánea. • Escalofríos. • Falta de apetito. • Náuseas.	Nominal.
		Señales de alarma: signos y síntomas de señales de signo de gravedad.		• Señales de alarma.	• Epistaxis. • Gingivorragia. • Dolor Abdominal persistente. • Disminución de la diuresis. • Vómitos persistentes. • Hepatomegalia. • Estado mental alterado • Disnea. • Pulso rápido y débil. • Hipotensión arterial.	Nominal.
Variable 2: Dengue	Se trata de una infección que puede afectar a personas desde los 0 años en adelante, que se transmite a través de la picadura del mosquito " <i>Aedes Aegypti</i> " (1,10,18,26).	Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y presenta fiebre de 2 a 7 días de evolución; y 2 o más signos y síntomas.	• Dengue sin señales de alarma	• Sin señales de alarma	• Si. • No.	Nominal.
		Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta 1 o más señales de alarma.	• Dengue con señales de alarma	• Con señales de alarma	• Si. • No.	Nominal

Referencias: 1, 10, 18,26

Fuente: Elaboración propia

**CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS-CLÍNICAS DE PACIENTES CON
DENGUE, CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN DE
LURIGANCHO, 2023**

N°	DIMENSIONES/Ítems	Pertinencia ¹	Relevancia ²	Claridad ³	Sugerencias
VARIABLE 1: Características epidemiológicas-clínicas					
DIMENSIÓN 1: Características epidemiológicas		Si	No	Si	No
1.	Sexo Masculino ☐ Femenino ☐				
2.	Edad Niños (< 12 años) ☐ Adolescentes (12-17 años) ☐ Adultos (18-59 años) ☐ Adultos mayores (> 59 años) ☐				
3.	Antecedente de dengue Sí ☐ No ☐				
4.	Hospitalizado Sí ☐ No ☐				
5.	Comorbilidades Hipertensión Arterial ☐ Diabetes Mellitus ☐ Enf. Renal crónica ☐ Hipotiroidismo ☐ Otros ☐ Ninguno ☐				
6.	Tipo de población Urbana ☐ Rural ☐				
7.	Mes de contagio Enero ☐ Febrero ☐ Marzo ☐ Abril ☐ Mayo ☐ Junio ☐ Julio ☐ Agosto ☐ Septiembre ☐ Octubre ☐ Noviembre ☐ Diciembre ☐				
DIMENSIÓN 2: Características clínicas		Si	No	Si	No
8.	Temperatura Hipotermia (<36.5°C) ☐ Normal (36.5°-37.5°C) ☐ Febrícula (37.6°- 37.9°C) ☐ Fiebre (>38.0°C) ☐ Hipertermia (>41.0°C) ☐				
9.	Escala de Glasgow: Leve ≥14 ☐ Moderado 9-13 ☐ Severo <8 ☐				
10.	Fiebre Sí ☐ No ☐				
11.	Artralgias Sí ☐ No ☐				
12.	Mialgias Sí ☐ No ☐				
13.	Cefalea Sí ☐ No ☐				
14.	Dolor retroocular Sí ☐ No ☐				
15.	Dolor lumbar Sí ☐ No ☐				
16.	Rash cutánea Sí ☐ No ☐				
17.	Escalofríos Sí ☐ No ☐				
18.	Falta de apetito Sí ☐ No ☐				
19.	Náuseas Sí ☐ No ☐				

20.	Epistaxis Sí ☐ No ☐							
21.	Gingivorragia Sí ☐ No ☐							
22.	Dolor abdominal Persistente Sí ☐ No ☐							
23.	Disminución de la diuresis Sí ☐ No ☐							
24.	Vómitos persistentes Sí ☐ No ☐							
25.	Hepatomegalia Sí ☐ No ☐							
26.	Estado mental alterado Sí ☐ No ☐							
27.	Disnea Sí ☐ No ☐							
28.	Pulso rápido y débil Sí ☐ No ☐							
29.	Hipotensión arterial Sí ☐ No ☐							
VARIABLE 2: Dengue								
DIMENSIÓN 1: Dengue sin señales de alarma		Si	No	Si	No	Si	No	
30.	Sin señales de alarma Sí ☐ No ☐							
DIMENSIÓN 2: Dengue con señales de alarma		Si	No	Si	No	Si	No	
31.	Con señales de alarma Sí ☐ No ☐ Epistaxis Sí ☐ Gingivorragia Sí ☐ Dolor abdominal persistente Sí ☐ Disminución de la diuresis Sí ☐ Vómitos persistentes Sí ☐ Hepatomegalia Sí ☐ Estado mental alterado Sí ☐ Disnea Sí ☐ Pulso rápido y débil Sí ☐ Hipotensión arterial. Sí ☐							

¹ **Pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiente: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [☐]

Aplicable después de corregir [☐]

No aplicable [☐]

Apellidos y nombres de juez validador: Dr./Mg. _____

DNI: _____

Especialidad del validador: _____

_____ de _____ de 2024.

Firma del experto informante

Anexo 4. Llenado del formato de validación del instrumento por los expertos

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS-CLÍNICAS DE PACIENTES CON DENGUE, CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2023

Nº	DIMENSIONES/Ítems	Pertinencia ¹	Relevancia ²	Claridad ³	Sugerencias
VARIABLE 1: Características epidemiológicas-clínicas					
DIMENSIÓN 1: Características epidemiológicas					
1.	Sexo Masculino ☐ Femenino ☐	X	X	X	
2.	Edad Niños (< 12 años) ☐ Adolescentes (12-17 años) ☐ Adultos (18-59 años) ☐ Adultos mayores (> 59 años) ☐	X	X	X	
3.	Antecedente de dengue Sí ☐ No ☐	X	X	X	
4.	Hospitalizado Sí ☐ No ☐	X	X	X	
5.	Comorbilidades Hipertensión Arterial ☐ Diabetes Mellitus ☐ Enf. Renal crónica ☐ Hipotiroidismo ☐ Otros ☐ Ninguno ☐	X	X	X	
6.	Tipo de población Urbana ☐ Rural ☐	X	X	X	
7.	Mes de contagio Enero ☐ Febrero ☐ Marzo ☐ Abril ☐ Mayo ☐ Junio ☐ Julio ☐ Agosto ☐ Septiembre ☐ Octubre ☐ Noviembre ☐ Diciembre ☐	X	X	X	
DIMENSIÓN 2: Características clínicas					
8.	Temperatura Hipotermia (<36.5°C) ☐ Normal (36.5°-37.5°C) ☐ Febrícula (37.6°- 37.9°C) ☐ Fiebre (>38.0°C) ☐ Hipertermia (>41.0°C) ☐	X	X	X	
9.	Escala de Glasgow: Leve ≥14 ☐ Moderado 9-13 ☐ Severo ≤8 ☐	X	X	X	
10.	Fiebre Sí ☐ No ☐	X	X	X	
11.	Artralgias Sí ☐ No ☐	X	X	X	
12.	Mialgias Sí ☐ No ☐	X	X	X	
13.	Cefalea Sí ☐ No ☐	X	X	X	
14.	Dolor retroocular Sí ☐ No ☐	X	X	X	
15.	Dolor lumbar Sí ☐ No ☐	X	X	X	
16.	Rash cutánea Sí ☐ No ☐	X	X	X	
17.	Escalofríos Sí ☐ No ☐	X	X	X	
18.	Falta de apetito Sí ☐ No ☐	X	X	X	
19.	Naúseas Sí ☐ No ☐	X	X	X	

20.	Epistaxis Sí ☐ No ☐	X		X		X	
21.	Gingivorragia Sí ☐ No ☐	X		X		X	
22.	Dolor abdominal Persistente Sí ☐ No ☐	X		X		X	
23.	Disminución de la diuresis Sí ☐ No ☐	X		X		X	
24.	Vómitos persistentes Sí ☐ No ☐	X		X		X	
25.	Hepatomegalia Sí ☐ No ☐	X		X		X	
26.	Estado mental alterado Sí ☐ No ☐	X		X		X	
27.	Disnea Sí ☐ No ☐	X		X		X	
28.	Pulso rápido y débil Sí ☐ No ☐	X		X		X	
29.	Hipotensión arterial Sí ☐ No ☐	X		X		X	
VARIABLE 2: Dengue							
DIMENSIÓN 1: Dengue sin señales de alarma							
30.	Sin señales de alarma Sí ☐ No ☐	X	No	X	No	X	No
DIMENSIÓN 2: Dengue con señales de alarma							
31.	Con señales de alarma Sí ☐ No ☐						
	Epistaxis Sí ☐						
	Gingivorragia Sí ☐						
	Dolor abdominal persistente Sí ☐						
	Disminución de la diuresis Sí ☐	X		X		X	
	Vómitos persistentes Sí ☐						
	Hepatomegalia Sí ☐						
	Estado mental alterado Sí ☐						
	Disnea Sí ☐						
	Pulso rápido y débil Sí ☐						
	Hipotensión arterial. Sí ☐						

¹ **Pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiente: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA

Opinión de aplicabilidad: ES APLICABLE

Aplicable ☒

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

Apellidos y nombres de juez validador: Dr./Mg. Eduardo Matos Prado

DNI: 07869101

Especialidad del validador: Medicine de Enfermedades Infecciosas y Tropicales

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "REGISPO ROAYEN"
Dr. EDUARDO D. MATOS PRADO
C.M.P. 30.118 R.P.E. 19064
JEFE DEL SERVICIO DE INFECTOLOGIA

04 de Setiembre de 2024.

Firma del experto informante

**CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS-CLÍNICAS DE PACIENTES CON
DENGUE, CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN DE
LURIGANCHO, 2023**

Nº	DIMENSIONES/Ítems	Pertinencia ¹	Relevancia ²	Claridad ³	Sugerencias
VARIABLE 1: Características epidemiológicas-clínicas					
DIMENSIÓN 1: Características epidemiológicas					
1.	Sexo Masculino ☐ Femenino ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
2.	Edad Niños (< 12 años) ☐ Adolescentes (12-17 años) ☐ Adultos (18-59 años) ☐ Adultos mayores (> 59 años) ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
3.	Antecedente de dengue Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
4.	Hospitalizado Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
5.	Comorbilidades Hipertensión Arterial ☐ Diabetes Mellitus ☐ Enf. Renal crónica ☐ Hipotiroidismo ☐ Otros ☐ Ninguno ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
6.	Tipo de población Urbana ☐ Rural ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
7.	Mes de contagio Enero ☐ Febrero ☐ Marzo ☐ Abril ☐ Mayo ☐ Junio ☐ Julio ☐ Agosto ☐ Septiembre ☐ Octubre ☐ Noviembre ☐ Diciembre ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
DIMENSIÓN 2: Características clínicas					
8.	Temperatura Hipotermia (<36.5°C) ☐ Normal (36.5°-37.5°C) ☐ Febrícula (37.6°- 37.9°C) ☐ Fiebre (>38.0°C) ☐ Hipertermia (>41.0°C) ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
9.	Escala de Glasgow: Leve ≥14 ☐ Moderado 9-13 ☐ Severo ≤8 ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
10.	Fiebre Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
11.	Artralgias Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☒ No ☐	
12.	Mialgias Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☒ No ☐	
13.	Cefalea Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
14.	Dolor retroocular Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☒ No ☐	
15.	Dolor lumbar Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☒ No ☐	
16.	Rash cutánea Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
17.	Escalofríos Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
18.	Falta de apetito Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
19.	Naúseas Si ☐ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	

20.	Epistaxis Si ☐ No ☐	X		X		X	
21.	Gingivorragia Si ☐ No ☐	X		X		X	
22.	Dolor abdominal Persistente Si ☐ No ☐	X		X		X	
23.	Disminución de la diuresis Si ☐ No ☐	X		X		X	
24.	Vómitos persistentes Si ☐ No ☐	X		X		X	
25.	Hepatomegalia Si ☐ No ☐	X		X		X	
26.	Estado mental alterado Si ☐ No ☐	X		X		X	
27.	Disnea Si ☐ No ☐	X		X		X	
28.	Pulso rápido y débil Si ☐ No ☐	X		X		X	
29.	Hipotensión arterial Si ☐ No ☐	X		X		X	
VARIABLE 2: Dengue							
DIMENSIÓN 1: Dengue sin señales de alarma		Si	No	Si	No	Si	No
30.	Sin señales de alarma Si ☐ No ☐	X		X		X	
DIMENSIÓN 2: Dengue con señales de alarma		Si	No	Si	No	Si	No
31.	Con señales de alarma Si ☐ No ☐	X		X		X	
	Epistaxis Si ☐	X		X		X	
	Gingivorragia Si ☐	X		X		X	
	Dolor abdominal persistente Si ☐	X		X		X	
	Disminución de la diuresis Si ☐	X		X		X	
	Vómitos persistentes Si ☐	X		X		X	
	Hepatomegalia Si ☐	X		X		X	
	Estado mental alterado Si ☐	X		X		X	
	Disnea Si ☐	X		X		X	
	Pulso rápido y débil Si ☐	X		X		X	
	Hipotensión arterial Si ☐	X		X		X	

¹ **Pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado

² **Relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiente: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable ☒

Aplicable después de corregir ☐

No aplicable ☐

Apellidos y nombres de juez validador: Dr./Mg. Dra Sandra Delgado Málaga

DNI: 10770190

Especialidad del validador: Médico Infectólogo

[Firma]
Dra Sandra Delgado Málaga
4R748 RNE 035141
Médico Infectólogo

5 de Septiembre de 2024.

Firma del experto informante

**CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS-CLÍNICAS DE PACIENTES CON
DENGUE, CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN DE
LURIGANCHO, 2023**

N°	DIMENSIONES/Items	Pertinencia ¹	Relevancia ²	Claridad ³	Sugerencias
VARIABLE 1: Características epidemiológicas-clínicas					
DIMENSIÓN 1: Características epidemiológicas		Si	No	Si	No
1.	Sexo Masculino ☐ Femenino ☐	X		X	
2.	Edad Niños (< 12 años) ☐ Adolescentes (12-17 años) ☐ Adultos (18-59 años) ☐ Adultos mayores (> 59 años) ☐	X		X	
3.	Antecedente de dengue Si ☐ No ☐	X		X	
4.	Hospitalizado Si ☐ No ☐	X		X	
5.	Comorbilidades Hipertensión Arterial ☐ Diabetes Mellitus ☐ Enf. Renal crónica ☐ Hipotiroidismo ☐ Otros ☐ Ninguno ☐	X		X	
6.	Tipo de población Urbana ☐ Rural ☐	X		X	
7.	Mes de contagio Enero ☐ Febrero ☐ Marzo ☐ Abril ☐ Mayo ☐ Junio ☐ Julio ☐ Agosto ☐ Septiembre ☐ Octubre ☐ Noviembre ☐ Diciembre ☐	X		X	
DIMENSIÓN 2: Características clínicas		Si	No	Si	No
8.	Temperatura Hipotermia (<36.5°C) ☐ Normal (36.5°-37.5°C) ☐ Febrícula (37.6°- 37.9°C) ☐ Fiebre (>38.0°C) ☐ Hipertermia (>41.0°C) ☐	X		X	
9.	Escala de Glasgow: Leve ≥14 ☐ Moderado 9-13 ☐ Severo ≤8 ☐	X		X	
10.	Fiebre Si ☐ No ☐	X		X	
11.	Artralgias Si ☐ No ☐	X		X	
12.	Mialgias Si ☐ No ☐	X		X	
13.	Cefalea Si ☐ No ☐	X		X	
14.	Dolor retroocular Si ☐ No ☐	X		X	
15.	Dolor lumbar Si ☐ No ☐	X		X	
16.	Rash cutánea Si ☐ No ☐	X		X	
17.	Escalofríos Si ☐ No ☐	X		X	
18.	Falta de apetito Si ☐ No ☐	X		X	
19.	Náuseas Si ☐ No ☐	X		X	

20.	Epistaxis Si ☐ No ☐	X		X		X	
21.	Gingivorragia Si ☐ No ☐	X		X		X	
22.	Dolor abdominal Persistente Si ☐ No ☐	X		X		X	
23.	Disminución de la diuresis Si ☐ No ☐	X		X		X	
24.	Vómitos persistentes Si ☐ No ☐	X		X		X	
25.	Hepatomegalia Si ☐ No ☐	X		X		X	
26.	Estado mental alterado Si ☐ No ☐	X		X		X	
27.	Disnea Si ☐ No ☐	X		X		X	
28.	Pulso rápido y débil Si ☐ No ☐	X		X		X	
29.	Hipotensión arterial Si ☐ No ☐	X		X		X	
VARIABLE 2: Dengue							
DIMENSIÓN 1: Dengue sin señales de alarma		Si	No	Si	No	Si	No
30.	Sin señales de alarma Si ☐ No ☐	X		X		X	
DIMENSIÓN 2: Dengue con señales de alarma		Si	No	Si	No	Si	No
31.	Con señales de alarma Si ☐ No ☐						
	Epistaxis Si ☐						
	Gingivorragia Si ☐						
	Dolor abdominal persistente Si ☐	X		X		X	
	Disminución de la diuresis Si ☐						
	Vómitos persistentes Si ☐						
	Hepatomegalia Si ☐						
	Estado mental alterado Si ☐						
	Disnea Si ☐						
	Pulso rápido y débil Si ☐						
	Hipotensión arterial Si ☐						

¹ **Pertinencia:** el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

² **Relevancia:** el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³ **Claridad:** se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiente: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Se hay suficiencia

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable ☒

Aplicable después de corregir ☐

No aplicable ☐

Apellidos y nombres de juez validador: Dr/Mg. Arleta Meza Hellen Valerie

DNI: 40909792

Especialidad del validador: Medico Cirujano


HELEN V. ARTETA MEZA
 MEDICO
 C.M.P. 64318

09 de septiembre de 2024.

Firma del experto informante

Anexo 5. Ficha de investigación clínico epidemiológica de Dengue del centro de salud.

PERÚ		Ministerio de Salud		Dirección General de Epidemiología		DENGUE																																																																													
Ficha de investigación clínico epidemiológica																																																																																			
I. DATOS GENERALES:					1. Fecha de investigación																																																																														
2. Dirección de Salud:					3. Red/ Micro Red/ Clas																																																																														
4. Establecimiento de salud notificante					E.S. I-1 ☐ E.S. I-3 ☐ E.S. II-1 ☐ E.S. I-2 ☐ E.S. I-4 ☐ E.S. II-2 ☐ E.S. III-1 ☐																																																																														
II. DATOS DEL PACIENTE					5. H.Clinica N°																																																																														
6. A. Paterno					7. D.N.I																																																																														
A. Materno					Telf																																																																														
Nombres					Fecha de nacimiento																																																																														
					8. Edad 9. Sexo																																																																														
10. Dirección					11. Localidad (AH, Urb, Resid, etc)																																																																														
					12. Distrito																																																																														
					13. Provincia																																																																														
					14. Departamento																																																																														
III. DATOS EPIDEMIOLOGICOS																																																																																			
Lugar donde probablemente se produjo la actual infección ¿En qué lugar o lugares estuvo en los últimos 14 días?																																																																																			
1.-																																																																																			
2.-																																																																																			
15. Departamento		16. Provincia		17. Distrito		18. Localidad (Cas., A.H., Urb., Resid., etc.)		19. Para S.I.G																																																																											
20. Tuvo dengue anteriormente: Si ☐ No ☐ Año																																																																																			
21. Vacunación Antiamarillica: Si ☐ No ☐ Año																																																																																			
IV. DATOS CLINICOS																																																																																			
22. Fecha de inicio de síntomas																																																																																			
23. Fecha de obtención de muestra																																																																																			
24. Signos y síntomas.																																																																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Manifestaciones de sangrado</th> <th style="text-align: left;">Señales de alarma</th> <th style="text-align: left;">Signos de choque</th> </tr> <tr> <td> <table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Fiebre</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Artralgias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Mialgias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Cefalea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor ocular</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor lumbar</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Erupción cutánea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Falta de apetito</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor de garganta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Náusea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>☐</td></tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Hematemesis (Vómito con sangre)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Melena (deposiciones negras)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Epistaxis (sangrado nasal)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Gingivorragia (Sangrado de encías)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Ginecorragia (sangrado transvaginal)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Petequias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Equimosis</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hematuria (Sangre en la orina)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Espujo hemoptico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Otros sangrados.....</td><td>☐</td></tr> </table> </td> <td> <table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Dolor abdominal intenso y continuo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor torácico o disnea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Vómitos persistentes</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución brusca de la T° o hipotermia</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución de la diuresis</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hepatomegalia o ictericia</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución de plaquetas</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Incremento del hematocrito</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Estado mental alterado (somnia o inquietud o irritabilidad o convulsión)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Derrame seroso al examen clínico (ascitis o derrame pleural o pericárdico)</td><td>☐</td></tr> </table> </td> </tr> </table>										Manifestaciones de sangrado	Señales de alarma	Signos de choque	<table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Fiebre</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Artralgias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Mialgias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Cefalea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor ocular</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor lumbar</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Erupción cutánea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Falta de apetito</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor de garganta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Náusea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>☐</td></tr> </table>	Si	No	Fiebre	☐	Artralgias	☐	Mialgias	☐	Cefalea	☐	Dolor ocular	☐	Dolor lumbar	☐	Erupción cutánea	☐	Falta de apetito	☐	Dolor de garganta	☐	Náusea	☐	Otros	☐	<table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Hematemesis (Vómito con sangre)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Melena (deposiciones negras)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Epistaxis (sangrado nasal)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Gingivorragia (Sangrado de encías)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Ginecorragia (sangrado transvaginal)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Petequias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Equimosis</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hematuria (Sangre en la orina)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Espujo hemoptico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Otros sangrados.....</td><td>☐</td></tr> </table>	Si	No	Hematemesis (Vómito con sangre)	☐	Melena (deposiciones negras)	☐	Epistaxis (sangrado nasal)	☐	Gingivorragia (Sangrado de encías)	☐	Ginecorragia (sangrado transvaginal)	☐	Petequias	☐	Equimosis	☐	Hematuria (Sangre en la orina)	☐	Espujo hemoptico	☐	Otros sangrados.....	☐	<table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Dolor abdominal intenso y continuo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor torácico o disnea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Vómitos persistentes</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución brusca de la T° o hipotermia</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución de la diuresis</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hepatomegalia o ictericia</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución de plaquetas</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Incremento del hematocrito</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Estado mental alterado (somnia o inquietud o irritabilidad o convulsión)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Derrame seroso al examen clínico (ascitis o derrame pleural o pericárdico)</td><td>☐</td></tr> </table>	Si	No	Dolor abdominal intenso y continuo	☐	Dolor torácico o disnea	☐	Vómitos persistentes	☐	Disminución brusca de la T° o hipotermia	☐	Disminución de la diuresis	☐	Hepatomegalia o ictericia	☐	Disminución de plaquetas	☐	Incremento del hematocrito	☐	Estado mental alterado (somnia o inquietud o irritabilidad o convulsión)	☐	Derrame seroso al examen clínico (ascitis o derrame pleural o pericárdico)	☐
Manifestaciones de sangrado	Señales de alarma	Signos de choque																																																																																	
<table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Fiebre</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Artralgias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Mialgias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Cefalea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor ocular</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor lumbar</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Erupción cutánea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Falta de apetito</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor de garganta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Náusea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>☐</td></tr> </table>	Si	No	Fiebre	☐	Artralgias	☐	Mialgias	☐	Cefalea	☐	Dolor ocular	☐	Dolor lumbar	☐	Erupción cutánea	☐	Falta de apetito	☐	Dolor de garganta	☐	Náusea	☐	Otros	☐	<table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Hematemesis (Vómito con sangre)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Melena (deposiciones negras)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Epistaxis (sangrado nasal)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Gingivorragia (Sangrado de encías)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Ginecorragia (sangrado transvaginal)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Petequias</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Equimosis</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hematuria (Sangre en la orina)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Espujo hemoptico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Otros sangrados.....</td><td>☐</td></tr> </table>	Si	No	Hematemesis (Vómito con sangre)	☐	Melena (deposiciones negras)	☐	Epistaxis (sangrado nasal)	☐	Gingivorragia (Sangrado de encías)	☐	Ginecorragia (sangrado transvaginal)	☐	Petequias	☐	Equimosis	☐	Hematuria (Sangre en la orina)	☐	Espujo hemoptico	☐	Otros sangrados.....	☐	<table border="0"> <tr><td>Si</td><td>No</td></tr> <tr><td>Dolor abdominal intenso y continuo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Dolor torácico o disnea</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Vómitos persistentes</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución brusca de la T° o hipotermia</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución de la diuresis</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hepatomegalia o ictericia</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Disminución de plaquetas</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Incremento del hematocrito</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Estado mental alterado (somnia o inquietud o irritabilidad o convulsión)</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Derrame seroso al examen clínico (ascitis o derrame pleural o pericárdico)</td><td>☐</td></tr> </table>	Si	No	Dolor abdominal intenso y continuo	☐	Dolor torácico o disnea	☐	Vómitos persistentes	☐	Disminución brusca de la T° o hipotermia	☐	Disminución de la diuresis	☐	Hepatomegalia o ictericia	☐	Disminución de plaquetas	☐	Incremento del hematocrito	☐	Estado mental alterado (somnia o inquietud o irritabilidad o convulsión)	☐	Derrame seroso al examen clínico (ascitis o derrame pleural o pericárdico)	☐													
Si	No																																																																																		
Fiebre	☐																																																																																		
Artralgias	☐																																																																																		
Mialgias	☐																																																																																		
Cefalea	☐																																																																																		
Dolor ocular	☐																																																																																		
Dolor lumbar	☐																																																																																		
Erupción cutánea	☐																																																																																		
Falta de apetito	☐																																																																																		
Dolor de garganta	☐																																																																																		
Náusea	☐																																																																																		
Otros	☐																																																																																		
Si	No																																																																																		
Hematemesis (Vómito con sangre)	☐																																																																																		
Melena (deposiciones negras)	☐																																																																																		
Epistaxis (sangrado nasal)	☐																																																																																		
Gingivorragia (Sangrado de encías)	☐																																																																																		
Ginecorragia (sangrado transvaginal)	☐																																																																																		
Petequias	☐																																																																																		
Equimosis	☐																																																																																		
Hematuria (Sangre en la orina)	☐																																																																																		
Espujo hemoptico	☐																																																																																		
Otros sangrados.....	☐																																																																																		
Si	No																																																																																		
Dolor abdominal intenso y continuo	☐																																																																																		
Dolor torácico o disnea	☐																																																																																		
Vómitos persistentes	☐																																																																																		
Disminución brusca de la T° o hipotermia	☐																																																																																		
Disminución de la diuresis	☐																																																																																		
Hepatomegalia o ictericia	☐																																																																																		
Disminución de plaquetas	☐																																																																																		
Incremento del hematocrito	☐																																																																																		
Estado mental alterado (somnia o inquietud o irritabilidad o convulsión)	☐																																																																																		
Derrame seroso al examen clínico (ascitis o derrame pleural o pericárdico)	☐																																																																																		
V. EXAMENES DE LABORATORIO																																																																																			
Cultivo																																																																																			
25. Aislamiento Viral																																																																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th>Fecha Toma de Muestra</th> <th>Serotipo</th> <th>Genotipo</th> <th>Negativo</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Fecha Toma de Muestra	Serotipo	Genotipo	Negativo																																																																						
Fecha Toma de Muestra	Serotipo	Genotipo	Negativo																																																																																
Serología																																																																																			
26. Ig M (Título)																																																																																			
27. Ig G (Título)																																																																																			
Conclusión (positivo o negativo)																																																																																			
1era. Muestra																																																																																			
2da. Muestra																																																																																			
28. PCR																																																																																			
Fecha Toma de Muestra																																																																																			
Reactivo																																																																																			
Si ☐ No ☐																																																																																			
Serotipo																																																																																			
Si ☐ No ☐																																																																																			
29. Confirmado por Laboratorio: Si ☐ No ☐																																																																																			
30. Confirmado por Nexo Epidemio: Si ☐ No ☐																																																																																			
31. Descartado Si ☐ No ☐																																																																																			
VI. EVOLUCION																																																																																			
32. El paciente fue hospitalizado: Si ☐ No ☐																																																																																			
33. Evolución de la enfermedad:																																																																																			
Favorable ☐																																																																																			
Fallecido ☐																																																																																			
Referido ☐																																																																																			
Fecha de fallecimiento																																																																																			
VII. CLASIFICACIÓN FINAL																																																																																			
34. Dengue sin señales de alarma ☐																																																																																			
35. Dengue con señal(es) de alarma ☐																																																																																			
36. Dengue grave ☐																																																																																			
VIII. PROCEDENCIA DEL CASO																																																																																			
37. Autóctono ☐																																																																																			
38. Importado nacional ☐																																																																																			
39. Importado internacional ☐																																																																																			
IX. OBSERVACIONES																																																																																			
X. INVESTIGADOR																																																																																			
Nombre de la persona responsable																																																																																			
Cargo:																																																																																			
Firma y Sello																																																																																			